

GALÓN · Curso de Cabo (ET)

Primeros auxilios — Guías ERC 2025 y Cruz Roja

Cuaderno de estudio: 50 preguntas con respuesta, explicación y referencia normativa. Elaboración PROPIA de GALÓN sobre fuentes oficiales verificadas (BOE, MINISDEF, IGN, ERC, Cruz Roja). Libre para uso personal; prohibida su venta. Generado 21-sep-2026. App: galon · banco auditado.

1. [F] La «P» del protocolo PAS (Proteger) consiste en:

A) Alejar el peligro y asegurarte de que ni tú, ni la víctima ni los demás sufran daño antes de actuar ✓

B) Proteger los bolsillos del herido

C) Cubrir la herida con la mano

D) Ponerse el casco

Explicación: Sin seguridad no hay socorro: si te lesionas, habrá DOS víctimas. Proteger siempre es el primer paso. · Ref: Cruz Roja · PAS

2. [F] El número único de emergencias válido en toda la Unión Europea es:

A) 066

B) 112 ✓

C) 911

D) 080

Explicación: El 112 es gratuito y funciona en toda la UE (en España coexiste con 061 sanitario y 091/092 policiales). · Ref: 112 · número único europeo

3. [F] En la RCP del adulto, el reanimador entrenado alterna:

A) 15 compresiones y 15 ventilaciones

B) 50 compresiones y 5 ventilaciones

C) 30 compresiones y 2 ventilaciones ✓

D) 2 compresiones y 30 ventilaciones

Explicación: Relación 30:2 confirmada por las guías ERC 2025 (si no sabes o no quieres ventilar: RCP solo manos, también válida). · Ref: ERC 2025 · SVB

4. [F] El ritmo correcto de las compresiones torácicas es:

A) Entre 40 y 60 por minuto

B) Entre 150 y 200 por minuto

C) Al azar, lo más rápido posible

D) Entre 100 y 120 por minuto ✓

Explicación: 100-120 compresiones por minuto (el compás de «Stayin' Alive»): menos no perfunde y más no llena el corazón. · Ref: ERC 2025 · SVB

5. [F] La profundidad de las compresiones en el adulto es:

A) Entre 1 y 2 centímetros

B) Entre 5 y 6 centímetros ✓

C) Entre 10 y 12 centímetros

D) Lo que aguante el paciente

Explicación: Al menos 5 cm y no más de 6: menos no genera flujo y más causa lesiones. Con reexpansión completa del tórax entre compresiones. · Ref: ERC 2025 · SVB

6. [F] Las interrupciones de las compresiones durante la RCP deben ser:

A) De hasta 1 minuto

B) Las necesarias para descansar

C) De menos de 10 segundos ✓

D) De 30 segundos tras cada ciclo

Explicación: Cada parada de compresiones frena el flujo sanguíneo cerebral: se cambian de reanimador o de ritmo en menos de 10 segundos. · Ref: ERC 2025 · SVB

7. [F] El DEA (desfibrilador externo automático) se conecta:

- A) Solo cuando llegue el médico
- B) Después de 30 minutos de RCP
- C) Solo si la víctima es mayor de 65 años
- D) En cuanto esté disponible, siguiendo sus instrucciones de voz ✓**

Explicación: La desfibrilación precoz es el eslabón que más vidas salva: el DEA analiza y descarga solo, guiando al socorrista con mensajes. · Ref: ERC 2025 · DEA

8. [F] La posición lateral de seguridad se aplica a una víctima:

- A) Inconsciente que respira con normalidad ✓**

- B) Consciente que camina
- C) Que no respira
- D) Con fractura abierta de pelvis

Explicación: Respira = no se hace RCP, pero hay que protegerle la vía aérea de vómito o lengua: boca arriba, la PLS lo garantiza. · Ref: Cruz Roja · PLS

9. [F] Ante una quemadura, después de apartar la fuente de calor, se enfría la zona:

- A) Con hielo directo 2 minutos
- B) Con mantequilla o pasta de dientes
- C) Con agua fresca en chorro suave, entre 10 y 20 minutos ✓**
- D) Soplando sobre la quemadura

Explicación: Cruz Roja: chorro suave de agua fría 10-15 minutos (otros protocolos hasta 20) o más si continúa el dolor. El frío corta el daño en profundidad. · Ref: Cruz Roja · quemaduras

10. [F] Con una quemadura con ampollas está PROHIBIDO:

- A) Taparla con una gasa limpia
- B) Enfriarla con agua fresca
- C) Apartar la fuente de calor
- D) Reventar las ampollas y aplicar hielo o remedios caseros ✓**

Explicación: La ampolla es un apósito biológico: reventarla abre la puerta a la infección; el hielo empeora el daño tisular. · Ref: Cruz Roja · quemaduras

11. [F] Ante un adulto consciente atragantado (no puede respirar ni hablar), se alterna:

- A) 5 golpes en la espalda con 5 compresiones abdominales ✓**
- B) 5 vaso de agua con 5 respiraciones
- C) Besarle el esternón con 5 palmadas en la frente
- D) Levantarlo las piernas con 5 sacudidas

Explicación: Hasta 5 golpes dorsales (talón de la mano, entre los omóplatos) alternando con hasta 5 compresiones abdominales (Heimlich). · Ref: ERC · obstrucción de vía aérea

12. [F] Ante una fractura de extremidad, la primera medida es:

- A) Tirar del miembro para alinearla
- B) Inmovilizarla tal como está, sin intentar encajarla ✓**
- C) Dar a la víctima un analgésico de botiquín
- D) Masajear la zona para quitar el dolor

Explicación: Encajar una fractura puede cortar arterias y nervios: se inmoviliza en la posición encontrada, cubriendo también la articulación de arriba y de abajo. · Ref: Cruz Roja · fracturas

13. [F] Con un cuchillo (u otro objeto) empotrado en una herida:

- A) Se tira de él con decisión
- B) Se gira antes de sacarlo
- C) Se lava con agua y se guarda para el médico

D) No se extrae: se fija con vendajes y se traslada ✓

Explicación: El objeto está «tapando» los vasos rotos: extraerlo libera la hemorragia. Se estabiliza y solo lo retira el personal sanitario. · Ref: Cruz Roja · heridas

14. [F] Ante una hemorragia externa moderada, la primera medida es:

A) Presionar directamente la herida con una gasa o paño limpio ✓

- B) Ponerle una cruz de cinta adhesiva
- C) Hacerle beber agua con azúcar
- D) Elevarle las piernas cinco minutos

Explicación: La presión directa corta la sangría en la mayoría de los casos; sobre ella, gasa y vendaje compresivo. · Ref: Cruz Roja · hemorragias

15. [F] Si se aplica un torniquete, SIEMPRE hay que:

- A) Tapanlo con la manga para que no se vea

B) Anotar la hora de colocación (en la frente del herido o en el propio torniquete) ✓

✓

- C) Aflojarlo cada 5 minutos
- D) Mojarlo para que no se pegue

Explicación: El equipo sanitario necesita saber cuánto lleva apretado: sin hora anotada pueden tomar decisiones equivocadas. · Ref: Control de hemorragias · torniquete

16. [F] Ante un herido en estado de shock sin traumatismo que lo impida, se le coloca:

- A) Sentado en una silla
- B) De pie, apoyado en un árbol
- C) Tumbado, con las piernas elevadas y abrigado ✓**
- D) Boca abajo con la cabeza colgando

Explicación: Elevar las piernas devuelve sangre al corazón y al cerebro; abrigar frena la pérdida de calor. Nunca se le dará de comer o beber. · Ref: Cruz Roja · shock

17. [F] A un herido grave NO se le debe:

A) Dar de beber o comer, aunque pida agua ✓

- B) Tapanlo con una manta
- C) Hablarle para tranquilizarle
- D) Avisar al 112

Explicación: Con cirugía potencial a la vista, la ingesta retrasa la anestesia y agrava hemorragias internas: se le humedecen los labios, nada más. · Ref: Cruz Roja · conducta ante heridos

18. [F] Durante una convulsión está PROHIBIDO:

- A) Apartar los objetos con los que pueda golpearse
- B) Meterle algo en la boca o sujetarle los brazos con fuerza ✓**
- C) Protegerle la cabeza con ropa doblada
- D) Cronometrar la duración de la crisis

Explicación: El mito de la «lengua tragada» provoca fracturas y ahogamiento: nada entre los dientes. Se protege, se cronometra y, si no despierta respirando normal, PLS. · Ref: Cruz Roja · convulsiones

19. [F] Ante una hemorragia nasal (epistaxis), la conducta correcta:

- A) Tumbado con la cabeza colgando hacia atrás
- B) Taponeándose la nariz con algodón seco durante un minuto
- C) Sentado, cabeza ligeramente hacia delante, presionando la ala de la nariz 10 minutos ✓**
- D) Echando agua fría en la frente

Explicación: La cabeza atrás hace tragar sangre (vómito y asfixia): adelante y presión. El mito del «cabeza atrás» está fuera de toda guía. · Ref: Cruz Roja · epistaxis

20. [F] Sobre una gasa empapada en sangre se debe:

- A) Retirla enjuagarla y volver a ponerla

- B) Sustituirla por un pañuelo de papel
- C) Dejar la herida al aire para que se seque

D) Añadir otra gasa encima sin retirar la anterior ✓

Explicación: Retirar la gasa arranca el coágulo que se estaba formando: se añaden capas y se aprieta más. · Ref: Cruz Roja · hemorragias

21. [M] Al llamar al 112 hay que comunicar:

- A) Solo el nombre del herido
- B) Qué ocurre, dónde exactamente, cuántos heridos hay y cómo están, sin colgar hasta que lo indiquen ✓**
- C) Únicamente la dirección y colgar enseguida
- D) Los datos del seguro médico

Explicación: La localización precisa y «no colgar» son vitales: con el altavoz puesto, el centralista guía al socorrista y localiza al equipo de emergencias. · Ref: 112 · cómo avisar

22. [M] Los eslabones de la cadena de supervivencia son:

- A) Comer, dormir, entrenar y zarpar
- B) Vacunar, curar, operar y recetar
- C) Reconocimiento precoz y aviso, RCP precoz, desfibrilación precoz y cuidados posteriores ✓**
- D) Llamar, esperar, huir y olvidar

Explicación: Cada eslabón encadena al siguiente: falla uno y la víctima muere. La desfibrilación precoz multiplica la supervivencia. · Ref: ERC 2025 · cadena de supervivencia

23. [M] La técnica correcta de las compresiones torácicas es:

- A) Sobre el esternón alto, con los dedos entrelazados apoyando en las costillas
- B) Con los codos doblados empujando lateralmente
- C) Sobre el lado izquierdo del pecho, sobre el corazón
- D) En el centro del pecho, brazos rectos, con el peso del cuerpo y permitiendo la reexpansión completa del tórax ✓**

Explicación: «Centro del pecho» (no a la izquierda), codos en extensión, tallo vertical usando el peso: y sin apoyarse nunca entre compresiones. · Ref: ERC 2025 · SVB

24. [M] El reanimador se cambia (o alterna) cada 2 minutos porque:

- A) La fatiga reduce la profundidad y la calidad de las compresiones sin que uno se dé cuenta ✓**
- B) Cada 2 minutos el corazón descansa
- C) El DEA hay que apagarlo cada 2 minutos
- D) La ley lo exige expresamente

Explicación: A los 2 minutos la calidad cae aunque el reanimador crea seguir bien: se aprovecha el análisis del DEA para cambiar. · Ref: ERC · calidad de la RCP

25. [M] Si no sabes o no quieres hacer ventilaciones (boca a boca), las guías ERC 2025 establecen que:

- A) No puedes hacer nada hasta llegar un médico
- B) Debes esperar a que la víctima respire
- C) La RCP solo con las manos (compresiones continuas) es una alternativa válida ✓**
- D) Solo vale la RCP con respiración artificial forzada

Explicación: ERC 2025 refuerza la RCP «solo manos» para el reanimador no entrenado o dubitativo: compresiones sin parar a 100-120/min. · Ref: ERC 2025 · resumen ejecutivo

26. [M] En un ahogamiento (y en el niño), la RCP comienza con:

- A) 10 compresiones sin ventilar nunca
- B) Aplicar el DEA dentro del agua
- C) Dar la vuelta a la víctima y sacudirla
- D) 5 ventilaciones iniciales antes de empezar las compresiones ✓**

Explicación: El paro por ahogamiento es hipóxico: primero aire. Por eso 5 ventilaciones de inicio (y en niño la parada suele ser también hipóxica). · Ref: ERC · ahogamiento y SVB pediátrico

27. [M] Si la víctima atragantada aún puede toser con eficacia:

A) No se le golpea la espalda: se le anima a seguir tosiendo ✓

B) Se le aplica el Heimlich inmediatamente

C) Se le cuelga de los pies

D) Se le da agua para «bajarla»

Explicación: La tos es el mejor mecanismo de expulsión: golpear o comprimir con tos eficaz puede empeorar la obstrucción. · Ref: ERC · obstrucción de vía aérea

28. [M] Si el atragantado pierde la consciencia, hay que:

A) Sentarlo y sacudirlo

B) Tumbarlo en el suelo e iniciar la RCP (compresiones) ✓

C) Echarle agua fría en la cara

D) Esperar tumbado junto a él diez minutos

Explicación: Las compresiones hacen de «maniobra de Heimlich» interna y generan presión: por eso se arranca la RCP sin dudar. · Ref: ERC · obstrucción de vía aérea

29. [M] La colocación correcta de un torniquete es:

A) Directamente sobre la herida sangrante

B) En el cuello o en la ingle si la herida es ahí

C) En el miembro sano, por simetría

D) Entre 5 y 7 cm por encima de la herida, sin apretarlo sobre una articulación ✓

Explicación: Ni sobre la herida ni sobre rodilla/codo (no aprieta): unos dedos por encima, y se estrecha hasta parar la sangría. · Ref: Control de hemorragias · torniquete

30. [M] Una vez apretado el torniquete y detenido el sangrado:

A) No se afloja: solo el personal sanitario decidirá retirarlo ✓

B) Se afloja cada 15 minutos «para irrigar»

C) Se retira a los 10 minutos en cualquier caso

D) Se afloja si el herido grita de dolor

Explicación: El mito del «aflojar cada 15 minutos» provoca re-sangrado y consumo de coágulos: moderno es apretar y no tocar hasta el hospital. · Ref: Control de hemorragias · torniquete

31. [M] Un miembro amputado (dedo, mano) debe:

A) Meterse en el bolsillo del herido directamente

B) Envolverse en gasa húmeda, meterse en bolsa impermeable y colocarse sobre hielo, sin contacto directo ✓

C) Enterrarse en la arena del camino

D) Congelarse pegado al hielo tal cual

Explicación: El frío directo mata el tejido: bolsa sobre hielo, sin tocarlo, acompañando siempre al herido. Cada hora cuenta. · Ref: Cruz Roja · amputaciones

32. [M] En una fractura abierta (hueso al aire):

A) Se reintroduce el hueso con un palo

B) Se lava el hueso con alcohol y se aprieta

C) No se empuja el hueso hacia dentro: se cubre con gasa estéril y se inmoviliza ✓

D) Se vendaje muy fuerte para «meterlo»

Explicación: Empujar el fragmento siembra la infección dentro: cubrir, inmovilizar y trasladar. · Ref: Cruz Roja · fracturas

33. [M] El tratamiento de un esguince (torcedura) reciente es:

A) Reposo, hielo/envoltura fría, compresión con vendaje y elevación ✓

B) Estiramiento fuerte del tobillo y marcha inmediata

C) Calor directo y masaje profundo con alcohol

D) Amarrar la extremidad con cuerda apretada

Explicación: El cuarteto clásico (reposo, frío, compresión, elevación) frena la hinchazón; el calor y el masaje la empeoran. · Ref: Cruz Roja · esguinces

34. [M] Lo PRIMERO ante cualquier quemadura es:

- A) Echarle agua sin más
- B) Apartar la fuente de calor (tapar sartén, desenchufar, alejar de la llama) ✓**
- C) Buscar un espejo para valorar la extensión
- D) Quitar la ropa pegada a la piel tirando

Explicación: Sin cortar el agente (fuego, corriente, producto) la quemadura sigue avanzando: primero cortar, después enfriar. · Ref: Cruz Roja · quemaduras

35. [M] En una quemadura química (ácido, lejía):

- A) Se neutraliza echando otro producto químico encima (ácido sobre lejía)
- B) Se espera a que el producto «seque» solo
- C) Se retira la ropa impregnada y se lava con agua abundante prolongadamente (más que en la térmica) ✓**
- D) Se tapa con plástico hermético y nada más

Explicación: Neutralizar con otro químico provoca reacción térmica: agua a chorro y a manta, quitando antes la ropa contaminada. · Ref: Cruz Roja · quemaduras químicas

36. [M] Ante un golpe de calor, la conducta es:

- A) Darle alcohol para «refrescarlo»
- B) Envolverlo en una manta para que sude
- C) Exponerlo al sol para que se aclimate
- D) Sombra, sitio fresco, aflojar la ropa, enfriar (agua, paños húmedos) y agua por boca SOLO si está consciente ✓**

Explicación: El alcohol dilata y deshidrata; la manta, mata. Enfriar el cuerpo y, si pierde consciencia, posición lateral y 112. · Ref: Cruz Roja · golpe de calor

37. [M] Las señales típicas de un estado de shock son:

- A) Rubor facial, piel caliente, pulso lento y fuerte
- B) Palidez, piel fría y sudorosa, pulso rápido y débil, sed y ansiedad ✓**
- C) Risa incontrolada y apetito normal
- D) Fiebre alta y erupción cutánea exclusivamente

Explicación: El cuerpo «apaga» piel y vísceras para mantener corazón y cerebro: frío, pálido, taquicárdico y sediento. · Ref: Cruz Roja · shock

38. [M] Si un insecto (o polvo) entra en el ojo:

- A) Frotar fuerte para sacarlo
- B) Sacarlo con la punta de un pañuelo seco
- C) No frotar: lavar con agua o suero abundante, con el ojo abierto o parpadeando bajo el agua ✓**
- D) Taponarlo con una venda apretada dos días

Explicación: Frotar incrusta el cuerpo extraño y raspa la córnea: se lava a manta y, si persiste el dolor, al médico. · Ref: Cruz Roja · cuerpo extraño en ojo

39. [M] Ante hipotermia (frío intenso, temblores, somnolencia):

- A) Frotar las extremidades con nieve
- B) Meter al herido en agua caliente
- C) Darle alcohol para «calentar por dentro»
- D) Abriga gradualmente el TRONCO con ropa seca y calor moderado; nunca fricción ni calor extremo directo ✓**

Explicación: El calor brusco dilata periferia y roba sangre del corazón; la fricción lesiona músculo frío. Seco, gradual y al tronco primero. · Ref: Cruz Roja · hipotermia

40. [M] Antes de curar una herida, el socorrista debe:

- A) Lavarse las manos y usar guantes (del botiquín o improvisados) ✓**
- B) Soplar sobre la herida para limpiarla

- C) Lamerse los dedos antes de tocar la gasa
- D) Usar la misma gasa para todas las heridas del grupo

Explicación: Autoprotección primero: guantes (improvisados con bolsa si no hay) contra sangre de desconocidos. · Ref: Cruz Roja · curas

41. [M] Para limpiar una herida superficial:

- A) Desde afuera hacia el centro, con algodón seco
- B) Se lava con alcohol y luego se espolvorea con azúcar
- C) Se limpia del CENTRO hacia AFUERA con suero o agua limpia, con gasa distinta en cada pasada ✓**
- D) Se deja sin limpiar: la sangre ya la limpia

Explicación: Del centro afuera (para no llevar suciedad a la herida) y sin algodón (se pega y deja fibras). · Ref: Cruz Roja · curas

42. [M] Tras una mordedura de serpiente está PROHIBIDO:

- A) Inmovilizar el miembro como una fractura
- B) Mantener la calma y reducir el movimiento
- C) Trasladar con urgencia al hospital (o llamar al 112)
- D) Hacer cortes, succionar la herida o poner torniquete ✓**

Explicación: Cortar y succionar no salva y necrosa; el torniquete concentra el veneno: inmovilizar, calmar y evacuar. · Ref: Cruz Roja · mordeduras

43. [D] Las guías ERC 2025 simplificaron la secuencia inicial del socorrista a:

- A) «Comprobar - Llamar - RCP» ✓**
- B) «Avisar - Rezar - Esperar»
- C) «Proteger - Curar - Transportar»
- D) «Respirar - Contar - Cantar»

Explicación: ERC 2025 (publicadas el 23-10-2025): comprobar respuesta y respiración, llamar al 112 (con altavoz) y comprimir YA. Menos pasos, más supervivencia. · Ref: ERC 2025 · secuencia SVB

44. [D] Un compañero sangra a chorro desde una pierna en plena maniobra. La conducta correcta:

- A) Elevarle la pierna y esperar a valorar con calma
- B) Torniquete INMEDIATO sobre la extremidad: la hemorragia masiva no admite demora ✓**
- C) Ponerle una gasa pequeña y seguir marchando
- D) Curar la herida después de descansar cinco minutos

Explicación: Ante hemorragia masiva de extremidad, el torniquete es PRIMERA elección (doctrina de control de hemorragias): cada minuto de sangrado mata. · Ref: Control de hemorragias · doctrina táctica · caso

45. [D] Llegas a un garaje en llamas con un herido dentro. Antes de valorarle la consciencia:

- A) Comprobarle el pulso radial dentro del garaje
- B) Iniciar la RCP dentro, entre las llamas
- C) Llamar al 112 y quedarse fuera para siempre
- D) Proteger: apagar o alejar el peligro y sacarlo de la zona (si es seguro), sin entrar sin protección ✓**

Explicación: PAS en acción: Proteger antes de Socorrer. Un socorrista quemado duplica las víctimas; valorar se hace fuera del peligro. · Ref: Cruz Roja · PAS · caso

46. [D] Estás reanimando; el DEA analiza y dice «no se aconseja descarga». Inmediatamente:

- A) Reanudas las compresiones (30:2) sin perder tiempo ✓**
- B) Esperas otro análisis antes de tocar al paciente
- C) Compruebas el pulso carotídeo un minuto largo
- D) Apagas el DEA y esperas a la ambulancia sentado

Explicación: Sea cual sea el dictamen del DEA, tras el análisis se comprime sin parar: el aparato reanaliza cada 2 minutos. · Ref: ERC 2025 · DEA · caso

47. [D] Un militar cae de un muro, se duele del cuello y nota hormigueo en los brazos. La conducta:

A) Sentarle para que «descanse el cuello»

B) No moverle el cuello ni el cuerpo (salvo peligro inmediato); inmovilizar el eje cabeza-cuello-tronco y avisar al 112 ✓

C) Girarle el cuello a ambos lados para valorar el rango

D) Levantarlo a andar despacio para ver si mejora

Explicación: El hormigueo delata lesión medular en ciernes: un giro mal dado puede agravar la lesión para siempre. Se inmoviliza y se evacúa. · Ref: Cruz Roja · lesión cervical · caso

48. [D] Tras un golpe en la cabeza, un compañero está lúcido... y a los 20 minutos queda somnoliento con vómitos. Sospechas:

A) Un simple mareo por el calor: le das agua y sigues

B) Que tiene hambre: le das un bocadillo

C) Hemorragia interna craneal (intervalo lúcido): 112 inmediato y vigilancia constante de su estado ✓

D) Que finge para saltarse la guardia: le gritas

Explicación: El «intervalo lúcido» es la firma del sangrado intracraneal: lucidez que se apaga + vómitos = emergencia vital ya. · Ref: Cruz Roja · traumatismo craneal · caso

49. [D] Estás SOLO ante un adulto inconsciente que no respira. El orden correcto:

A) Llamar primero al 112 (con altavoz) y luego iniciar las compresiones ✓

B) Comprimir 30 minutos y llamar después

C) Ir corriendo a buscar a alguien y volver tarde

D) Ventilarle dos minutos antes de pensar en llamar

Explicación: En el adulto el paro es cardíaco: ayuda primero. (En niño y ahogamiento, paro hipóxico: 1 minuto de RCP ANTES de dejar a la víctima para llamar.) · Ref: ERC 2025 · llamar · caso

50. [D] En la cantina un compañero se atraganta, deja de toser y pierde la consciencia. Lo correcto:

A) Sostenerlo de pie y seguir dándole palmadas una hora

B) Tumbarlo en el suelo y comenzar la RCP con compresiones ✓

C) Colgarlo del tobillo desde la barra

D) Meterle los dedos a ciegas hasta el fondo de la garganta

Explicación: Consciente: golpes y Heimlich. Inconsciente: al suelo y a comprimir (cada compresión empuja el cuerpo extraño). · Ref: ERC · obstrucción · caso